

La cystite interstitielle, également appelée syndrome de la vessie douloureuse (IC/BPS), est une affection chronique associant **douleur, pression ou gêne au niveau de la vessie ou du pelvis** et un **besoin fréquent ou urgent d'uriner** — **sans** infection sous-jacente. L'inconfort s'intensifie souvent quand la vessie se remplit et diminue après la miction. La condition se gère bien, même s'il n'existe pas de traitement unique.

## À propos de cette affection

L'IC/BPS n'est pas une infection et n'est pas contagieuse. Les symptômes varient d'une personne à l'autre et évoluent par **poussées** (périodes de crises) et par phases plus calmes.

Manifestations courantes :

- Douleur, pression ou gêne au niveau de la vessie ou du pelvis
- Besoin fréquent et/ou urgent d'uriner, de jour comme de nuit
- Gêne qui **s'aggrave lorsque la vessie se remplit** et s'atténue après la miction
- Poussées pouvant être déclenchées par certains aliments, le stress ou le cycle menstruel

## Causes

La cause exacte est inconnue. Elle implique probablement une muqueuse vésicale sensible ou irritée, des nerfs hypersensibles et, souvent, un **plancher pelvien tendu et hyperactif**. Comme plusieurs facteurs sont en jeu, le traitement combine généralement plusieurs approches.

## COMPRENDRE LES TERMES

### IC/BPS

Cystite interstitielle / syndrome de la vessie douloureuse (IC/BPS) — douleur et urgences vésicales sans infection.

### Poussée

Période de symptômes aggravés, souvent déclenchée par des aliments ou le stress.

### Diagnostic d'exclusion

Posé après avoir écarté d'autres causes (comme une infection).

### Rééducation du plancher pelvien

Kinésithérapie visant à relâcher les muscles pelviens contractés.

### Instillation vésicale

Médicament apaisant introduit dans la vessie par une sonde fine.

### Lésion de Hunner

Zone spécifique de la paroi vésicale visible chez certains patients, traitable directement.

### Cystoscopie

Examen de l'intérieur de la vessie à l'aide d'une petite caméra.

**EST-CE QUE ÇA VA S'AMÉLIORER ?** L'IC/BPS est le plus souvent chronique, mais la plupart des patients obtiennent un vrai soulagement en combinant les traitements et en identifiant leurs déclencheurs. L'objectif est de réduire la fréquence et l'intensité des poussées pour mener une vie normale — trouver la bonne combinaison demande parfois du temps, soyez patient.

## Comment on le diagnostique

Il n'existe pas de test unique. Le diagnostic repose sur vos symptômes, après avoir écarté d'autres causes :

- Une **analyse d'urine** pour exclure une infection ou la présence de sang
- Un historique des symptômes et un **calendrier mictionnel**
- Parfois une **cystoscopie** pour rechercher une lésion de Hunner

## Comment on le traite (étape par étape)

- 1 **Autosoins** — identifiez vos **aliments déclencheurs**, gérez le stress et le sommeil, pratiquez une rééducation vésicale progressive.
- 2 **Kinésithérapie du plancher pelvien** — pour relâcher les muscles contractés (attention : les contractions forcées de type Kegel peuvent aggraver les symptômes).
- 3 **Médicaments** — traitements oraux et **instillations vésicales** apaisantes.
- 4 **Traitements ciblés et avancés** — traitement d'une lésion de Hunner ou stimulation nerveuse dans les cas résistants.

## Vivre avec l'IC/BPS

- Déclencheurs fréquents : **café, thé, alcool, agrumes, tomates et plats épicés** — supprimez-les un à un, puis réintroduisez-les pour identifier les vôtres.
- Prévoyez un **plan en cas de poussée** (repos, chaleur, hydratation, aliments doux).
- Le stress et un plancher pelvien tendu entretiennent le cercle vicieux — les activités douces et la relaxation aident.

### Appelez votre équipe soignante si vous avez :

- De la fièvre, des frissons ou une douleur au dos/flanc (possible infection)
- Du **sang dans les urines** apparu récemment
- Une poussée incontrôlable ou une impossibilité d'uriner

## TROIS CHOSES À RETENIR

1. L'IC/BPS est une douleur pelvienne/vésicale avec urgences qui n'est **pas** une infection — chronique, mais très gérable.
2. Le traitement combine autosoins et contrôle des déclencheurs, kinésithérapie du plancher pelvien, médicaments et instillations, et soins ciblés si nécessaire.
3. Identifiez vos déclencheurs alimentaires et de stress, et ayez un plan en cas de poussée. Sang dans les urines, fièvre ou douleur au flanc doivent être signalés.